

TRAUMATISMOS Y LESIONES MÁS FRECUENTES DEL DEPORTISTA - MMII



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

PATOLOGÍA EN CADERA O PELVIS

Las caderas son muy estables. Cuando están sanas, hace falta mucha fuerza para lastimarlas. Sin embargo, algunas veces los deportes, correr o el uso excesivo o las caídas pueden conducir a lesiones en las caderas, las cuales incluyen:

- Distensiones
- Bursitis
- Luxaciones
- Fracturas

El tratamiento de los problemas de las caderas puede incluir reposo, medicinas, fisioterapia o cirugía, incluyendo el reemplazo de cadera.

SACROILEÍTIS

Es la inflamación de la articulación sacroilíaca. Esta afección puede ser unilateral. Es difícil de diagnosticar, ya que tarda en mostrarse en la radiografía. El retraso del diagnóstico de esta patología provoca una continua destrucción de la articulación y la aparición de abscesos (infección e inflamación del tejido)





Dentro de las causas de este trastorno están:

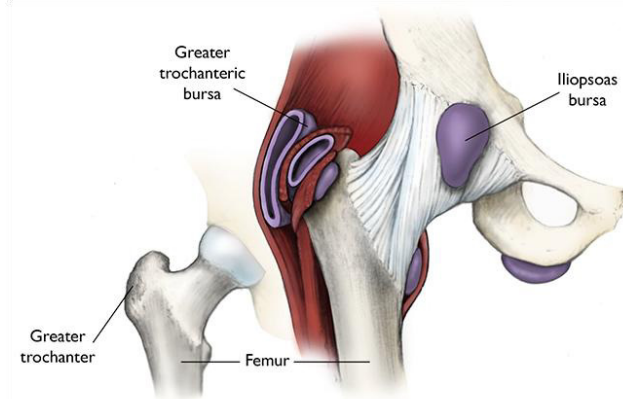
- * Traumas en la zona
- * Embarazo
- * Infecciones
- * Osteomielitis

Las principales manifestaciones clínicas de la sacroileítis son:

- * Dolor.
- * Pérdida de rango de movimiento.
- * Fiebre (si de fondo hay infección).
- * Sensibilidad aumentada en la zona.
- * Contracturas musculares de músculos adyacentes.

BURSITIS DE CADERA

- La bursitis de cadera afecta con mayor frecuencia a la bolsa que cubre el trocánter mayor del fémur, aunque la bolsa del psoasilíaco también puede inflamarse.
- La bursitis es una inflamación de la bolsa. Hay dos bolsas principales en la cadera que normalmente se irritan e inflaman. Una bursa cubre el punto óseo del hueso de la cadera llamado trocánter mayor. La inflamación de esta bolsa se llama bursitis trocantérea.
- Otra bursa, la bursa iliopsoas, se encuentra en el interior (lado de la ingle) de la cadera. Cuando esta bolsa se inflama, la afección también se conoce como bursitis de cadera, pero el dolor se localiza en el área de la ingle. Esta afección no es tan común como la bursitis trocantérea, pero se trata de manera similar.



SÍNTOMAS

- El síntoma principal de la bursitis es el dolor en la zona de la cadera. El dolor generalmente se extiende al exterior del área del muslo.
- En las primeras etapas, el dolor generalmente se describe como agudo e intenso. Más tarde, el dolor puede volverse más intenso y extenderse a un área más grande de la cadera.
- El dolor suele ser peor por la noche, al acostarse sobre la cadera afectada y al levantarse de una silla después de estar sentado un rato. También puede empeorar al caminar, subir escaleras o ponerse en cuclillas de forma prolongada.

CAUSAS

- Lesión por estrés repetitivo (uso excesivo). Esto puede ocurrir al correr, subir escaleras, andar en bicicleta o estar de pie durante largos períodos de tiempo.
- Lesión de cadera. Una lesión en la punta de la cadera puede ocurrir cuando se cae sobre la cadera, se golpea la cadera o se acuesta sobre un lado del cuerpo durante un período prolongado.
- Enfermedad de la columna. Esto incluye escoliosis, artritis de la columna lumbar (inferior) y otros problemas de la columna.
- Desigualdad a lo largo de las piernas. Cuando una pierna es significativamente más corta que la otra, afecta la forma en que camina y puede provocar la irritación de la bolsa de la cadera.
- Artritis reumatoide. Esto hace que sea más probable que la bolsa se inflame.

TENDINITIS ANSERINA

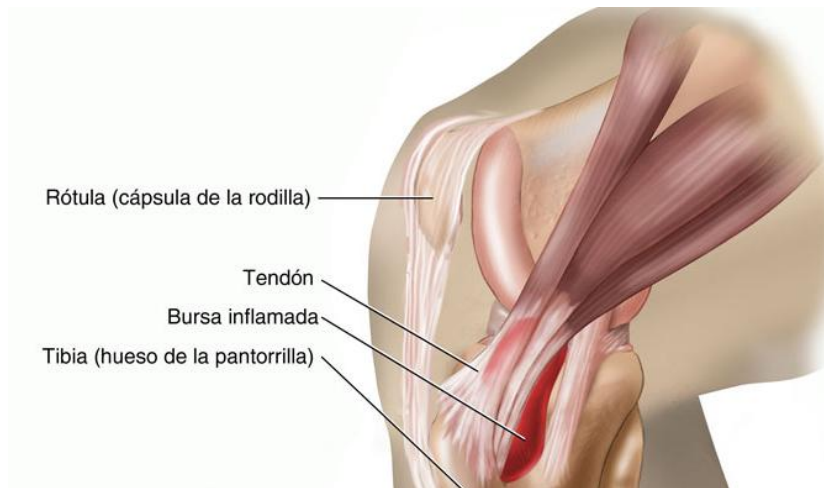
La tendinitis anserina, conocida también como “tendinitis de pata de ganso” es una inflamación de un grupo de tendones que tienen una inserción en común. Estos músculos y sus tendones que forman tal estructura son:

- Semitendinoso
- Sartorio
- Recto interno



SÍNTOMAS

- Dolor persistente en la parte anterior e interna de la tibia a nivel de la rodilla.
- Dolor al presionar sobre la zona de inserción de estos tres músculos.
- Puede aparecer inflamación sobre la zona dolorosa.
- Dolor sobretodo por las mañanas al levantarnos.
- Dolor en situaciones como levantarse de una silla o salir del coche.



TENDINITIS ROTULIANA

Es una lesión de la rodilla bastante común en ciclistas, runners, jugadores de voleibol, baloncesto, fútbol y atletas profesionales. Por esta razón, a menudo también se la conoce como “rodilla del saltador”, aunque en realidad puede afectar a cualquier persona cuya actividad habitual conlleve un gran esfuerzo para las articulaciones de las rodillas, ya sea por prácticas deportivas que incluyen saltos frecuentes, o por motivos laborales o por su estilo de vida.

Consiste en la lesión del tendón rotuliano cuya misión es enlazar la tibia con la rótula.

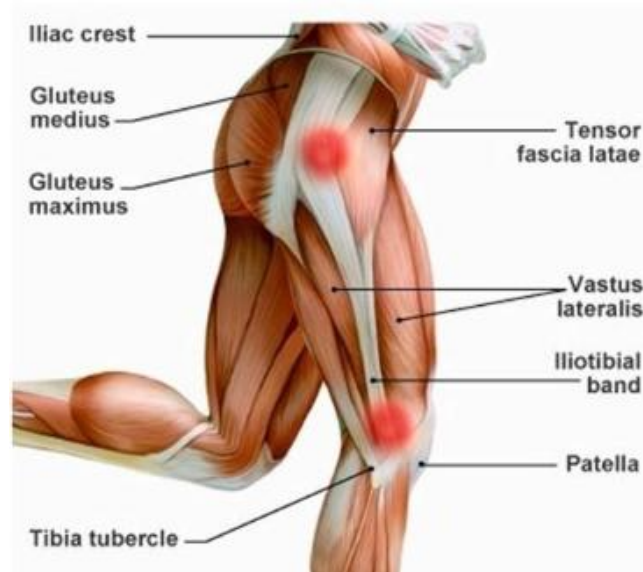


CAUSAS

- Las causas más habituales de la tendinitis rotuliana suelen estar relacionadas con los pequeños microtraumatismos que se producen de forma frecuente durante ejercicios como correr y saltar sobre superficies duras o pedalear en exceso.
- Estos ejercicios realizados de manera intensa o sin la progresión y adaptación adecuada a la actividad física fuerzan el tendón rotuliano, obligándolo a sufrir una gran tensión que provoca microdesgarros y conllevan la aparición de inflamaciones y dolores.

SÍNDROME DE LA BANDA ILIOTIBIAL

- El Síndrome de la Banda o Cintilla Iliotibial que corresponde a una inflamación del tendón (tendinitis) del músculo tensor de la fascia lata, el cual se produce a causa de una fricción de la banda iliotibial al rozar sobre el cóndilo externo de la rodilla durante los movimientos de flexión y extensión.
- La banda iliotibial es una banda gruesa del tejido fibroso que se extiende desde la pelvis (iliaco), cubriendo la articulación de la cadera por la parte externa de la pierna, hasta insertarse en la tibia.
- En muchas ocasiones se asocia a un varo de rodilla que favorece el mecanismo de lesión de la cintilla sobre el cóndilo femoral.



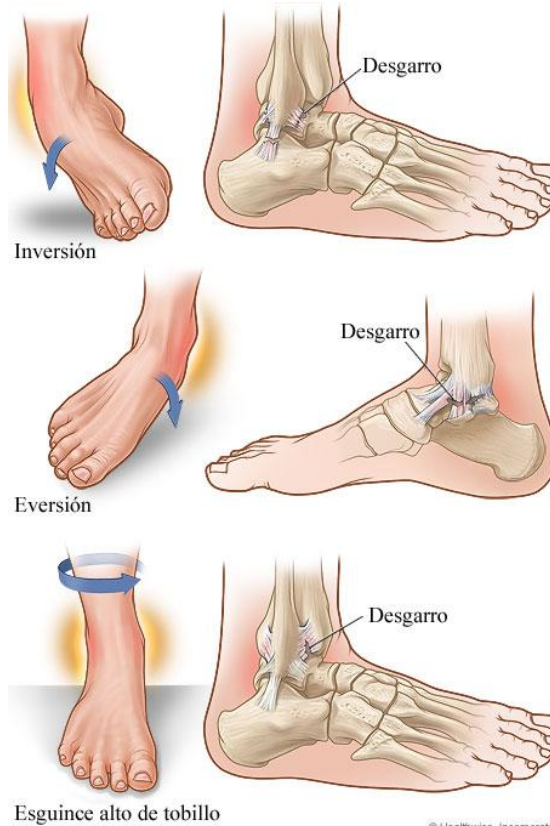
CAUSAS

- Una cintilla iliotibial naturalmente estrecha o ancha puede hacer que seas más susceptible a esta lesión.
- La debilidad en los músculos abductores de la cadera, concretamente el glúteo medio; nos llevará a sobre-tensar la fascia lata.
- La pronación excesiva o una biomecánica pobre del pie (tendencia al pie plano) pueden aumentar el riesgo de esta lesión. Si el pie rueda hacia adentro o se aplana, la parte inferior de la pierna gira y también lo hace la rodilla, lo que aumenta la posibilidad de fricción en la banda.
- Otros factores incluyen la diferencia de longitud de las piernas (dismetría), realizar trail o cross, o correr frecuentemente en descenso.

ESGUINCE DE TOBILLO

- Traumatismo de tracción ligamentosa que compromete la integridad de los ligamentos: **peroneo astragalino anterior (PAA)**, **peroneo astragalino posterior (PAP)** y **calcáneo peroneo (CP)**.
- Se produce principalmente por un mecanismo de **inversión** y el grado de afectación puede variar (grados: 1, 2 y 3), dependiendo de la estabilidad de la articulación, el terreno, calzado, factores propios de la persona, etc.





SÍNTOMAS

Dependerá del grado de afectación, pero tomaremos en cuenta el grado 2 como ejemplo (más común para tratamiento).



Dolor en la zona de lesión (generalmente en lateral)

Pérdida de la funcionalidad al apoyo y esfuerzo

Hematoma

Aumento de temperatura

Inflamación

A basketball player in a white jersey with red accents and the number 15 is lying on his back on a wooden basketball court. He is holding his right leg with both hands, indicating a significant injury. He is wearing white sneakers with red laces. In the background, several people in black clothing, likely coaches or staff, are watching the scene. The text "GRACIAS POR SU ATENCIÓN" is overlaid in the bottom right corner.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN